

Lactante febril sin foco

Bibliográfica Hospital Perrupato – Dr. Navarro David – 2019

Libro de Infectología SAP 2012

Consenso 2017 SAP

Definición

“Enfermedad febril aguda sin causa evidente después de una adecuada anamnesis y un examen clínico minucioso”.

A menor edad, mayor es el riesgo de infección bacteriana grave. En los primeros meses de vida, la inmadurez del sistema inmune lleva a un déficit en la opsonización, en la función macrofágica y en la actividad de los neutrófilos. Hasta los 2 años, la producción de IgM e IgG específica frente a bacterias capsuladas no es adecuada. También es importante indagar sobre la vacunación.

Un registro térmico de 38,5°C o 2 registros de 38°C, en un lactante menor de tres meses sin foco clínico aparente para la fiebre.

El aumento de temperatura puede ocurrir como consecuencia de sobrecalentamiento, lo cual es más común en los menores de 3 meses y, de manera particular, en el neonato. Cuando exista esta sospecha, se debe desnudar al niño y volver a tomar la temperatura a los 15-30 minutos. Si el niño no presenta entonces fiebre, y no ha tomado antipiréticos, puede considerarse afebril. El grado de fiebre no es un criterio de riesgo hasta los 90 días. En cambio, en el niño mayor de 3 meses, la fiebre alta sí es un factor de riesgo. (Asociación Española de Pediatría)

Epidemiología

- El riesgo de infección bacteriana grave es mayor en menores de 3 meses (4 a 10%)
- Los niños pequeños pueden tener hipotermia asociada a infecciones graves.

Etiología

< 1 mes:

- *Escherichia coli*
- Bacterias Gram-positivas, como *Enterococcus* spp., *SGB*, *Spn* y *Staphylococcus aureus*
- Streptococo del grupo B (el uso de profilaxis intraparto para prevención de la sepsis por SGB se relacionó con una disminución de la prevalencia de este agente)
- *Klebsiella* spp.
- *Enterobacter* spp.
- *Neisseria meningitidis* (Nm)
- *Hib*
- *Salmonella* spp.
- Si bien *Listeria monocytogenes* es un agente probable, casi no hay referencias en nuestro país

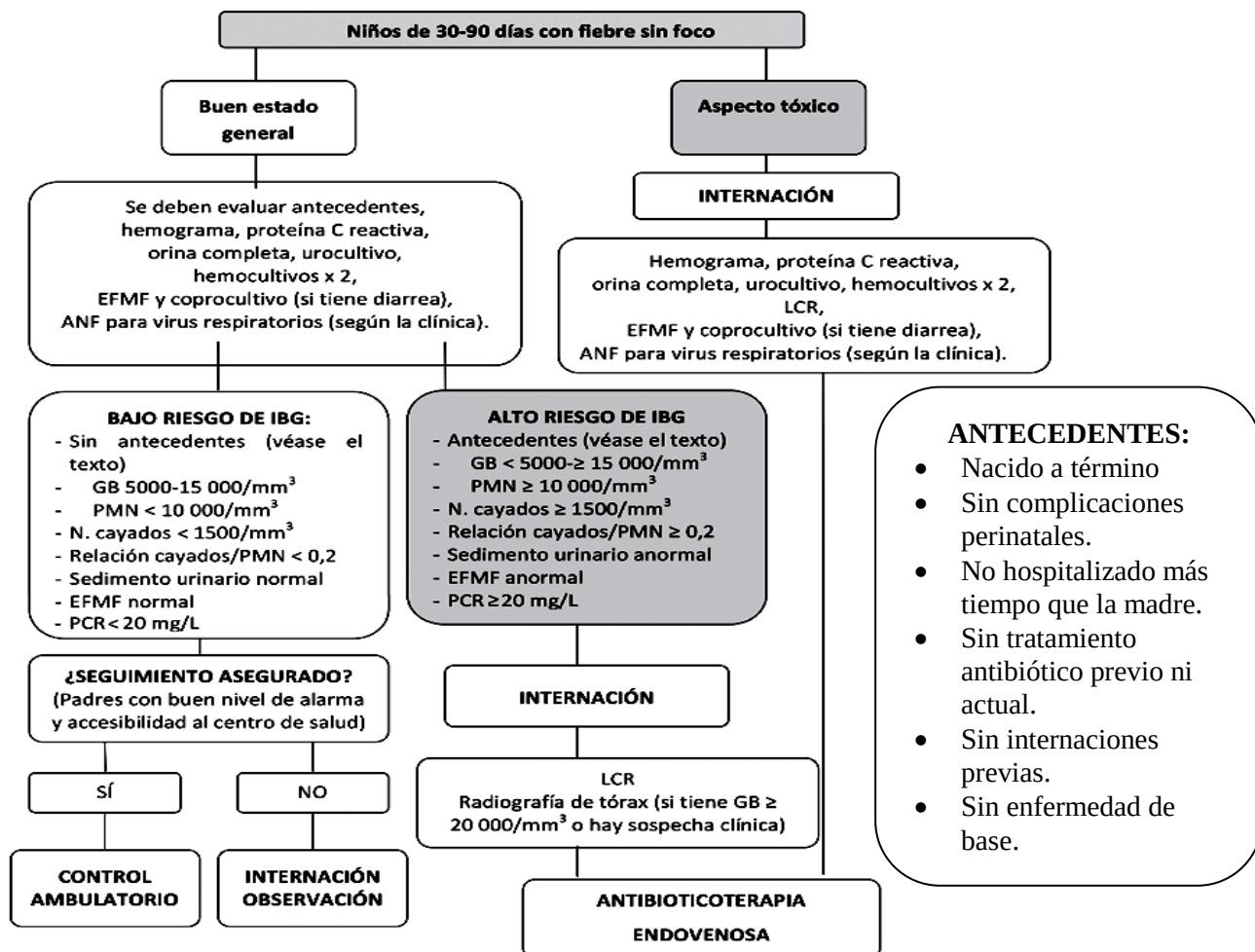
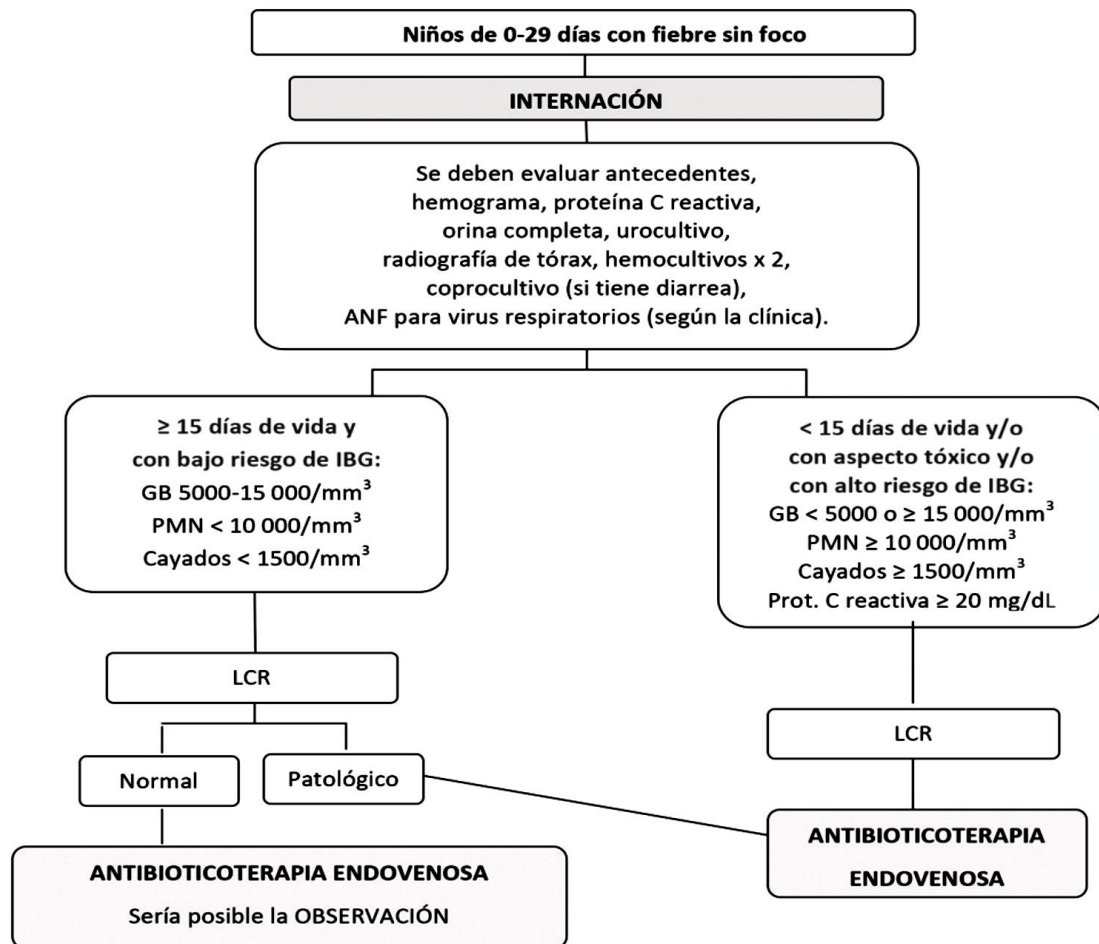
Se solicita:

- Hemograma Completo
- VSG Y PCR
- Orina completa
- Rx de tórax
- Siempre internar y pancultivar

Tratamiento: ampicilina + gentamicina. De no poder descartar meningitis, cefotaxima + ampicilina

El riesgo de IBG es considerable y puede deteriorarse rápidamente. Teniendo en cuenta que no existen criterios de laboratorio que, solo o combinado, permitan descartar con seguridad IBG, la evidencia disponible no avala el abordaje ambulatorio de estos niños.

Algoritmos



Etiologías en pacientes de 1 - 3 meses:

- Síndromes virales: 60% (las más frecuentes, por rotavirus, VSR y enterovirus, otros menos frecuentes son el rinovirus, influenza A y B, parainfluenza y adenovirus)
- Streptococo pneumoniae (90% de las causas bacterianas)
- Neisseria meningitidis
- Streptococo grupo B
- Salmonella

Diagnóstico y tratamiento

Criterios Rochester: Deben cumplirse TODOS los criterios; NO se cumplen **ALTO riesgo**

1. Buen aspecto general.
2. Lactante previamente sano:
 - Nacido a término (>37 semanas)
 - No tratado de hiperbilirrubinemia inexplicada.
 - No recibió ni está recibiendo antibióticos.
 - No hospitalizaciones previas.
 - Sin enfermedad crónica o de base.
3. No foco evidente de infección de piel, tejidos blandos, osteoarticular u oído (los estudios recientes no consideran la otitis media como una situación de riesgo, ya que, posteriormente a la introducción de la vacuna contra *Hib*, no se observó mayor incidencia de bacteriemia en niños con esta patología)
4. Valores de laboratorio:
 - Leucocitos entre 5.000-15.000/mm³
 - Recuento de cayados < 1.500/mm³
 - Recuento de neutrófilos < 10 000/mm³
 - Relación cayados/polimorfonucleares totales < 0,2
 - Proteína C reactiva < 20 mg/L o procalcitonina < 0,05 ng/ml
 - < 10 leucocitos/campo en sedimento urinario, sin piuria
 - < 5 Leucocitos/campo en fresco heces (si diarrea)

A todos estos pacientes se les deberán realizar 2 hemocultivos y urocultivo. Hay que tener en cuenta que hasta 50% de los niños con ITU puede tener sedimento urinario normal en la evaluación inicial. En aquellos lactantes mayores de 2 meses en buen estado general con probable ITU, no es necesario realizar PL y puede indicarse tratamiento ambulatorio, si el seguimiento está asegurado.

Los niños con bajo riesgo de IBG (infección bacteriana grave) podrán ser controlados en forma ambulatoria si sus padres tienen buen nivel de alarma, comprenden las indicaciones y tienen accesibilidad al centro de salud. Se realizará seguimiento clínico estricto y control de cultivos a las 24 horas.

Aquellos pacientes en estado crítico o con aspecto tóxico deben ser tratados de inmediato, aun antes de la realización de estudios si estos ocasionaran demora.

“Esta es una guía de diagnóstico y tratamiento, cada paciente debe ser evaluado individualmente para evaluar la necesidad de estudios complementarios y tratamiento.”

Tratamiento

200-300 mg/kg/día de ampicilina endovenosa cada 6 horas + 80-100 mg/kg/día de Ceftriaxona endovenosa cada 12-24 horas o 150 mg/kg/día de cefotaxima cada 8 horas.

La proteína C reactiva comienza a elevarse pasadas las 12 horas del inicio de la enfermedad, con valores altos en IBG, y puede demorar 3-7 días en disminuir con tratamiento adecuado y/o mejoría clínica.

La procalcitonina asciende más velozmente que la proteína C reactiva, con pico a las 6-8 horas, alcanza una meseta a las 12 horas y desciende a las 48-72 horas del inicio del tratamiento adecuado y/o de la mejoría clínica. Los valores menores de 0,05 ng/ml se relacionan con bajo riesgo de IBG; los mayores de 2 ng/ml, con sepsis.

Si bien esta prueba ha demostrado tener buena correlación con IBG, su valor predictivo negativo no es del 100%.

La velocidad de eritrosedimentación aumenta en forma tardía, con baja sensibilidad y especificidad para detectar IBG.

La ITU es la IBG más frecuente y se diagnostica en 4%-16% de los lactantes < 3 meses con FSF. La posibilidad de bacteriemia secundaria en este grupo varía entre 3% y 30%. Pasada la etapa neonatal, los pacientes con ITU en buen estado general, con o sin bacteriemia, evolucionan favorablemente cuando son tratados con el antibiótico adecuado. Es importante diferenciar la bacteriemia de la sepsis o *shock* séptico.

Se define **bacteriemia** al desarrollo bacteriano en los hemocultivos, que puede representar bacteriemia verdadera o contaminantes, mientras que la sepsis es un evento clínico agudo con alteración de la función de órganos ocasionado por la respuesta a una infección, independientemente del diagnóstico microbiológico.

Existe evidencia que avala el abordaje ambulatorio de los niños mayores de 2 meses con ITU, en buen estado general y con seguimiento asegurado, sin realizar hemocultivos ni PL.

Con respecto al riesgo de neumonía, se recomienda solicitar radiografía de tórax con recuento de leucocitos mayores de 20 000/mm³, dado el riesgo de neumonía oculta.

La identificación de infección viral disminuye, pero no descarta la posibilidad de IBG. En lactantes con alto riesgo, la probabilidad de IBG es significativamente menor (del 5,5%) si se documenta infección viral. La IBG más frecuente con infección viral concomitante es la ITU. Del 2% al 5% de los pacientes menores de 90 días infectados con virus sincicial respiratorio (VSR) y hasta el 5% de aquellos con influenza pueden tener ITU.²⁵ La coinfección viral-bacteriana se asocia más frecuentemente a fiebre > 39 °C y leucocitos > 20 000/mm³.

Lactantes febril entre 3 y 6 meses

Un niño de 3 meses o más con FSF en buen estado general difícilmente presente enfermedad grave.

El riesgo de bacteremia en esta edad es del 3-11%.

El riesgo de que un paciente con FSF presente neumonía oculta aumenta de modo considerable si tiene fiebre $\geq 39^{\circ}\text{C}$ con leucocitosis $\geq 20000/\text{mm}^3$, y su prevalencia es de hasta 20% en estos casos. Se justifica la solicitud de radiografía de tórax solo cuando presenten estas características.

Con fiebre < 39 °C y < 24-48 horas de evolución. No se justifica la realización de estudios complementarios en niños con FSF de esta edad que cumplan estas características.

Escala de Yale: 3-36 meses

	NORMAL	MODERADA	GRAVE
COLOR	Rosado	Extremidades pálidas o acrocianosis	Palidez o Cianosis
RESPUESTA SOCIAL	Sonríe - Alerta	Sonríe o alerta brevemente	No sonríe No alerta
REACCIONA AL ESTIMULO CON LOS PADRES	Llora brevemente y calma	Llanto intermitente	Llanto continuo o responde con dificultad
CALIDAD DEL LLANTO	Tono normal o no llora	Sollozando	Débil
HIDRATACIÓN	Normohidratado	Deshidratación leve	Deshidratación moderada a grave
CONCIENCIA	NORMAL	Tendencia al sueño	No se despierta

- YOS ≤ 10 puntos: Riesgo bajo
- YOS ≥ 10 puntos: Riesgo alto

Varias publicaciones avalan el abordaje ambulatorio y sin antibióticos en niños que se encuentran en buen estado general, pero con parámetros de laboratorio de riesgo, siempre y cuando sean posibles controles periódicos minuciosos que incluyan la lectura de los cultivos realizados.

El inicio del ATB con 50 mg/kg/día (en nuestro hospital recomendamos a 80mg/Kg/día) de ceftriaxona es una conducta posible en pacientes pequeños, especialmente los menores de 6 meses, temperatura elevada y falta de cobertura frente a *Hib* y *Spn*.

Si bien la bacteremia oculta disminuyó luego de la incorporación de las vacunas conjugadas, *Spn* sigue siendo el microorganismo más frecuente.

Como un alto porcentaje puede autolimitarse, la conducta ante hemocultivos positivos para esta bacteria dependerá del estado del niño. Si el paciente dejó de tener fiebre, presenta buen estado general, sin foco infeccioso y no fue medicado, se controlará ambulatoriamente sin antibioticoterapia ni realización de nuevos estudios. En el caso de que hubiera sido medicado y persistiera sin foco, continuará el tratamiento antibiótico para la BO (*Tabla*). Ante hemocultivos positivos para *Spn* y persistencia de la fiebre, se internará para completar la evaluación y el tratamiento.

Algoritmo

